PSIQUIATRIA

Transtornos relacionados ao álcool e outras drogas

Resumo de tutoria

NESTE CADERNO

Conteúdo de estudo, quadros, figuras e referências dos materiais fornecidos.

14 páginas de conteúdo • Texto pesquisável • Navegação por marcadores

Edição visual padronizada. Conteúdo clínico mantido a partir dos arquivos de origem; esta edição não constitui revisão ou atualização das condutas.

RESUMO · PSIQUIATRIA · CLÍNICA MÉDICA

Transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas

O essencial para entender, diagnosticar e conduzir — tipo por tipo, com o manejo de cada quadro e o projeto terapêutico singular do caso da tutoria

1. Discutir os transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas.
2. Diagnosticar os transtornos por uso de substância, com enfoque na dependência do álcool.
3. Compreender o manejo ambulatorial e hospitalar da síndrome de abstinência alcoólica e sua prevenção.
4. Discutir as estratégias e políticas para o tratamento da dependência química.
5. Discutir as repercussões clínicas do uso de álcool.
6. Entender a segurança do paciente com síndrome de abstinência alcoólica.

FORMATO **RESUMO** · TEMA **ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS** · **2026** · VERSÃO **3** · CONTEÚDO VERIFICADO EM **OUTUBRO/2026**

SEÇÃO 1

Conceitos e diagnóstico

O que separa o hábito da doença é o comportamento — perda de controle e uso apesar do dano —, não a quantidade isolada.

O consumo forma um espectro: uso de baixo risco, uso de risco, uso nocivo (já com dano) e dependência. **Tolerância** e **abstinência** traduzem adaptação do organismo (dependência física) e não bastam para o diagnóstico: quem usa opioide para dor oncológica é tolerante, mas não tem transtorno. O **transtorno por uso de substância** se define pela perda de controle, pela prioridade crescente dada ao consumo e pela persistência apesar do dano.

A dependência é uma adaptação cerebral. Toda droga de abuso aumenta a dopamina no circuito de recompensa, que "aprende" a repetir a experiência e associa a ela lugares, horários e pessoas. Com a repetição, a recompensa fica hipofuncionante e os sistemas de estresse, hiperativos: a pessoa passa a beber para deixar de se sentir mal (reforço negativo), enquanto o córtex pré-frontal, que deveria frear o impulso, perde eficiência. O álcool libera opioides endógenos nesse circuito, e é por isso que a naltrexona, um antagonista opioide, reduz o prazer de beber.

No Brasil, cerca de **2,3 milhões de pessoas** preenchiam critérios de dependência de álcool no III Levantamento Nacional [1], e o consumo abusivo nas capitais subiu de 15,6% para 18,8% entre 2006 e 2019, quase só à custa das mulheres — a **convergência entre os sexos** [2]. Não há dose comprovadamente segura: o álcool é carcinógeno do grupo 1 [3].

1.1 Rastreamento e diagnóstico

Pergunte a todos, em qualquer cenário, com instrumento validado [ASAM 2020] [4]. O **AUDIT** (10 perguntas, 0 a 40 pontos) já indica a conduta: até 7, educação; 8 a 15, orientação simples; 16 a 19, aconselhamento breve e monitorização; 20 ou mais, encaminhamento para avaliação e tratamento especializado [5]. O CAGE (duas ou mais respostas positivas) sugere dependência, mas deixa passar o bebedor de risco.

O **DSM-5** exige pelo menos **2 de 11 critérios em 12 meses**: leve com 2 ou 3, moderado com 4 ou 5, grave com 6 ou mais. Os critérios cobrem perda de controle (inclusive a **fissura**, que entrou), prejuízo social, uso arriscado e os critérios farmacológicos (tolerância e abstinência); os problemas legais saíram [6]. A CID-10, ainda usada no SUS, separa uso nocivo (F10.1), dependência (F10.2), abstinência (F10.3) e abstinência com delirium (F10.4) [7].

Os exames sustentam a suspeita e ajudam no seguimento. A **GGT** sobe com o consumo recente e normaliza em semanas de abstinência; o **VCM** demora meses e reflete consumo crônico; **AST/ALT acima de 2** sugere lesão alcoólica. Alcoolemia alta num paciente que não parece intoxicado revela tolerância e anuncia abstinência grave [7]. Toda avaliação inclui outras drogas, comorbidade psiquiátrica e **risco de suicídio** [4].

Para o bebedor de risco, a **intervenção breve** na própria consulta reduz o consumo; o tom depende do estágio motivacional de Prochaska e DiClemente, e a **entrevista motivacional** (perguntas abertas, escuta reflexiva, sem confronto) ajuda o paciente a avançar [prática consagrada].

Tipo de quadro	O que é	Onde está
Intoxicação aguda	Depressão do sistema nervoso proporcional à dose e inversa à tolerância	Seção 2
Abstinência não complicada	Hiperexcitação nas primeiras horas sem álcool, com o paciente orientado	Seções 3 e 4.1
Convulsão de abstinência	Crise generalizada precoce, nas primeiras 48 horas	Seção 4.2

Tipo de quadro	O que é	Onde está
Alucinose alcoólica	Alucinações, sobretudo auditivas, com consciência preservada	Seção 4.3
Delirium tremens	Abstinência com delirium e instabilidade autonômica	Seção 4.4
Wernicke e Korsakoff	Lesão neurológica por falta de tiamina	Seção 4.5
Transtorno por uso	A doença de base, crônica e recidivante	Seção 6

Tabela 1 — Os tipos de quadro relacionados ao álcool; cada um tem manejo próprio. As outras drogas estão na Seção 8.

SEÇÃO 2

Intoxicação alcoólica aguda

O maior perigo, no pronto-socorro, é a embriaguez esconder outra doença.

O álcool deprime o sistema nervoso em degraus: primeiro a desinibição, depois a incoordenação, a fala arrastada e o nistagmo (100 a 150 mg/dL), o delirium e a letargia (150 a 300 mg/dL), a perda de consciência (300 a 400 mg/dL) e, a partir de 400 mg/dL, o risco de morte por depressão respiratória ou arritmia [8]. Esses valores valem para quem não tem tolerância; o etilista crônico pode estar lúcido com uma alcoolemia que comataria outra pessoa.

O erro clássico é atribuir à embriaguez um rebaixamento com outra causa: **hematoma subdural** após queda (o etilista tem plaquetopenia e coagulopatia), **hipoglicemia**, hipotermia, infecção, outras drogas e **Wernicke**. Alcoolemia baixa com estado mental alterado obriga a procurar outra explicação [8].

O manejo é de suporte. Proteger a via aérea (decúbito lateral; intubação se houver apneia ou ventilação inadequada), medir a **glicemia capilar** em todos e dar **tiamina 100 mg IV** sempre que se usarem líquidos venosos [8]. A hidratação venosa fica para hipotensão ou desidratação, porque não acelera a eliminação do etanol [8]. Tomografia de crânio se houver trauma, sinal focal ou rebaixamento desproporcional ou que não melhora [prática consagrada]. A alta depende da resposta clínica, não de uma alcoolemia específica [8] — e a consulta é a chance de rastrear e antecipar a abstinência. Na **cetoacidose alcoólica** (binge, jejum, vômitos, acidose com ânion gap aumentado e glicemia normal ou baixa), o tratamento é soro fisiológico, glicose e tiamina, sem insulina [prática consagrada].

SEÇÃO 3

Abstinência alcoólica: bases e gravidade

O cérebro que se adaptou a funcionar "freado" pelo álcool dispara quando o freio é retirado de repente.

O etanol reforça a inibição (receptor GABA-A, o mesmo dos benzodiazepínicos) e reduz a excitação (bloqueia o receptor NMDA de glutamato). Com o uso diário, o sistema nervoso se reequilibra no sentido oposto: a resposta GABAérgica diminui, os receptores NMDA aumentam e o freio da noradrenalina perde sensibilidade [7]. Quando o álcool sai, essas adaptações ficam sem contrapeso. A falta de inibição produz ansiedade, insônia e tremor; o excesso de NMDA deixa o córtex propenso a convulsões; e a noradrenalina sem freio explica taquicardia, hipertensão, sudorese, midríase e febre [7].

Daí a lógica do tratamento: o **benzodiazepínico** repõe a inibição que faltou e é o único que previne convulsão e delirium, enquanto clonidina e betabloqueador só abafam os sinais adrenérgicos [4]. Daí também o **kindling**: cada abstinência sensibiliza o cérebro para a próxima, e abstinências graves prévias são o melhor preditor de uma nova abstinência grave [4].

Os sintomas começam cerca de **6 horas** após parar ou reduzir, às vezes com alcoolemia ainda positiva [7]. A maioria fica na forma não complicada; uma minoria evolui para convulsão, alucinose ou delirium tremens, cada uma com sua janela (Figura 1).

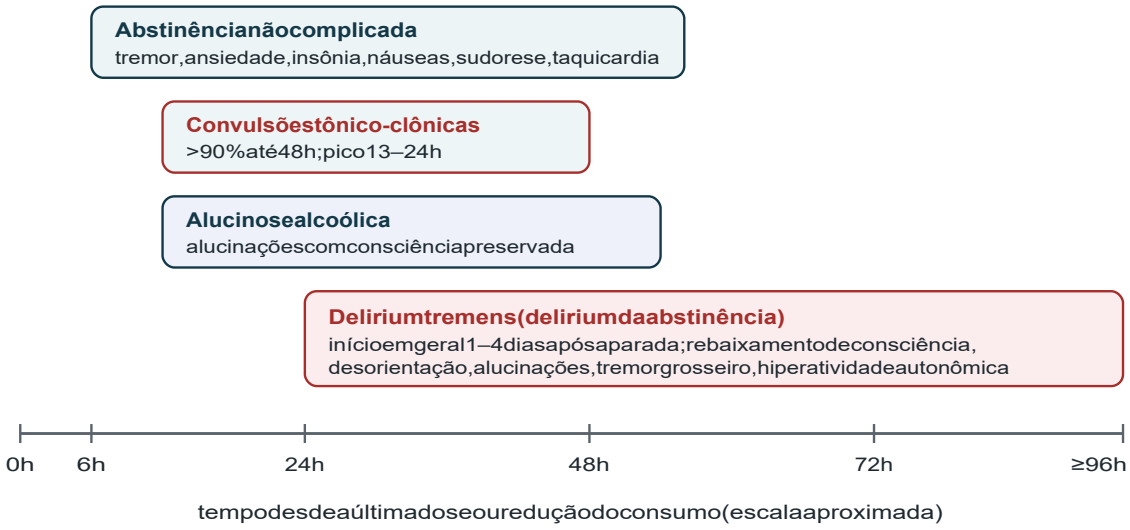


Figura 1 — Janelas temporais das manifestações da abstinência alcoólica. As janelas se sobrepõem e variam entre pacientes; os tempos seguem o consenso da Associação Brasileira de Psiquiatria [7]. Em internados de baixo risco com abstinência leve, a ASAM considera improvável a evolução para formas graves após 36 horas de observação [4]. Esquema autoral.

A **CIWA-Ar** (10 itens) mede a gravidade de uma abstinência já reconhecida — menor que 10, leve; 10 a 18, moderada; 19 ou mais, grave [4] —, mas não diagnostica, porque febre, infecção e hipoglicemia também pontuam, e exige paciente comunicativo. Para prever complicação antes dos sintomas, a ASAM recomenda nos internados a **PAWSS**: escore de **4 ou mais** identificou abstinência complicada com sensibilidade de 93% e especificidade de 99,5% [4,9]. Elevam o risco delirium ou convulsão prévios, várias abstinências anteriores, doença aguda associada, idade acima de 65 anos e sinais de abstinência com alcoolemia positiva [4,7].

O consenso da ABP, a referência nacional mais cobrada, usa dois níveis [7]. No **nível I**, tremor fino, sudorese discreta, náuseas sem vômitos, paciente orientado, com família e sem comorbidade grave: tratamento ambulatorial. No **nível II**, agitação, tremor generalizado, vômitos, convulsão, desorientação, alucinações, rede social ausente ou comorbidade grave: hospital. O suporte social entra na decisão. No diferencial, afaste sempre hipoglicemia, Wernicke, hematoma subdural, infecção, encefalopatia hepática e outras drogas — a maior parte das complicações nasce de avaliação incompleta [4,7].

SEÇÃO 4

Manejo da abstinência, tipo a tipo

Benzodiazepínico e tiamina são comuns a todos; o local, a via e a dose mudam conforme o tipo.

4.1 Abstinência não complicada

O quadro é de tremor fino, sudorese, ansiedade, insônia, náuseas e taquicardia leve, com o paciente **orientado**. O **ambulatório** serve para quem tem abstinência leve ou moderada sem fatores complicadores, sem convulsão ou delirium prévios, sem comorbidade importante e com alguém que acompanhe [4]: diazepam até **20 mg/dia** VO em doses divididas, reduzido até a suspensão em cerca de uma semana (lorazepam até 4 mg/dia no hepatopata ou idoso frágil) [ABP 2000] [7], tiamina, reavaliação diária por até cinco dias, comprimidos sob a guarda de um familiar, sem dirigir e com orientação para voltar se houver confusão, alucinação, convulsão, vômitos ou febre [4,7]. Indicam internação a abstinência grave ou complicada, vômitos persistentes, confusão, doença clínica ou psiquiátrica descompensada, risco de suicídio e falta de rede de apoio [4,7]; a Figura 2 resume a decisão.

No **hospital**, o ambiente é calmo e a CIWA-Ar é aplicada a cada 1 a 4 horas nas primeiras 24 horas [4]. O esquema preferido é o **guiado por sintomas** (dose só quando o escore passa do limiar), que reduz a dose total e o tempo de internação; no alto risco, usa-se a **dose de ataque**, por exemplo diazepam 20 mg a cada hora até CIWA-Ar abaixo de 10 [4]. Os de ação longa (diazepam) dão retirada suave; no hepatopata grave ou idoso frágil, **lorazepam**, sem metabólitos ativos [4,7]. Magnésio só se houver hipomagnesemia, arritmia ou convulsão prévia [4]. Clonidina e betabloqueador são apenas adjuvantes [ASAM 2020] [4].

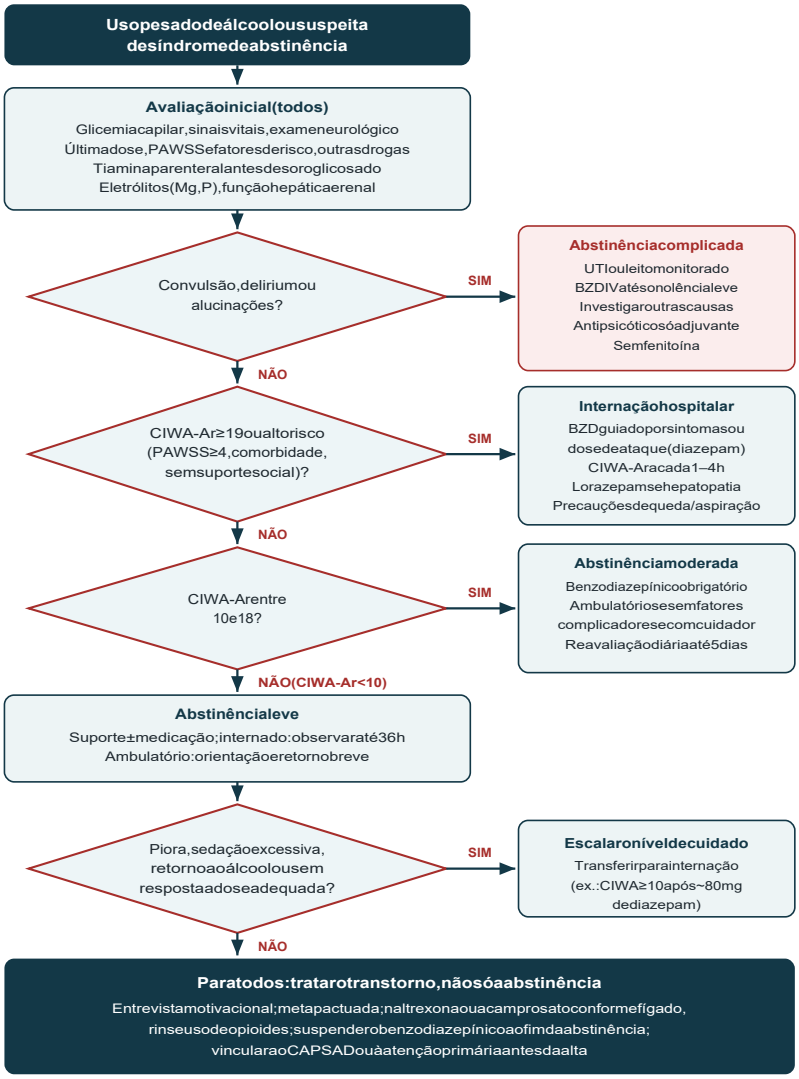


Figura 2 — Fluxograma de conduta na síndrome de abstinência alcoólica. Gravidade pela CIWA-Ar e local de tratamento conforme a ASAM [4]; níveis de comprometimento e cuidados gerais conforme o consenso brasileiro [7]. BZD = benzodiazepínico. Esquema autoral.

Fármaco	Ambulatório	Internação domiciliar	Hospital (CIWA-Ar acima de 8 a 10)
Diazepam	Até 20 mg/dia VO, retirada em 1 semana	Até 40 mg/dia VO	10 a 20 mg VO a cada hora; IV no máximo 10 mg em 4 minutos
Lorazepam	4 mg/dia VO	8 mg/dia VO	2 a 4 mg VO a cada hora; até 12 mg/dia no delirium

Tabela 2 — Doses do consenso brasileiro [7]; a dose adequada é a que controla os sintomas.

4.2 Convulsão de abstinência

Crise tônico-clônica generalizada, precoce (mais de 90% nas primeiras 48 horas, pico entre 13 e 24 horas) e em pequeno número; ocorre em cerca de 5% dos não tratados, e um terço deles evolui para delirium [7]. É marcador de gravidade. Crise focal, tardia, repetida ou com exame neurológico alterado pede outra causa (trauma, hipoglicemia, hiponatremia, infecção) [4,8]. Trata-se com benzodiazepínico IV de ação rápida — lorazepam 1 a 3 mg se as crises se repetirem ou durarem mais de 2 a 3 minutos [8] —, internação, esquema de ataque e reavaliação a cada 1 a 2 horas por 6 a 24 horas [4]. A **fenitoína não funciona** e não é usada [4,7].

4.3 Alucinose alcoólica

Alucinações sobretudo **auditivas** (vozes ameaçadoras ou depreciativas) com a **consciência preservada** e pouca instabilidade autonômica; o DSM-5 a classifica como transtorno psicótico induzido [4,7]. Trata-se a abstinência com benzodiazepínico e, sobre essa base, **haloperidol 5 mg/dia** [7]; a clorpromazina é evitada porque baixa o limiar convulsivo [7]. Se as alucinações persistem semanas depois da abstinência, pense em psicose primária.

4.4 Delirium tremens

É a forma mais grave e uma emergência. Começa em geral entre o primeiro e o quarto dia: consciência flutuante, desorientação, alucinações visuais e táteis, agitação, tremor grosseiro, febre, taquicardia e sudorese profusa; a mortalidade historicamente citada vai de 5% a 25% [7]. Raramente vem sozinho — procure pneumonia aspirativa, trauma, hipoglicemia, distúrbios eletrolíticos e Wernicke [4,7]. O que separa o delirium da alucinose é a **consciência**.

O paciente vai para **leito monitorado** (em geral UTI), em jejum, com cabeceira elevada, glicemia, **tiamina em dose de tratamento** (está confuso e o Wernicke não pode ser excluído) [10], hidratação guiada pela volemia e reposição de potássio, magnésio e fósforo [4,7]. O alvo do benzodiazepínico é a **sonolência leve, calma e despertável**; doses muito altas podem ser necessárias e não devem ser negadas, com vigilância respiratória [4]. Delirium por mais de 72 horas pede reavaliação [4].

Etapa	Conduta
Primeira linha	Benzodiazepínico IV em bolus: diazepam 10 mg dobrando a cada 10 a 15 minutos, ou lorazepam 1 a 2 mg a cada 10 minutos, até a sedação leve [8]
Adjuvantes	Haloperidol se agitação e alucinações persistirem apesar do benzodiazepínico; clonidina ou dexmedetomidina para sinais adrenérgicos — nunca isolados [4,7]
Refratário	Fenobarbital 120 a 240 mg IV a cada 20 minutos; depois, infusão contínua (midazolam, propofol, dexmedetomidina), em geral com ventilação mecânica [4,8]

Tabela 3 — Tratamento do delirium tremens por etapas.

4.5 Wernicke e Korsakoff

A tiamina é cofator do metabolismo da glicose; o etilista come pouco e a absorve mal, e uma carga de glicose aumenta a demanda, levando à falência dos neurônios do tálamo medial e dos corpos mamilares [10]. A tríade — confusão, ataxia e alteração oculomotora — é incompleta na maioria; pelos **critérios de Caine**, bastam dois de quatro: deficiência nutricional, alteração oculomotora, disfunção cerebelar e alteração mental [10]. O tratamento é **tiamina pelo menos 200 mg IV ou IM três vezes ao dia**, antes de carboidrato [10]. A sequela é a **síndrome de Korsakoff**: amnésia anterógrada e confabulação.

RACIOCÍNIO CLÍNICO — TIAMINA NA PREVENÇÃO

A **ABP** recomenda 300 mg/dia IM por 7 a 15 dias e glicose só depois da tiamina [7]; a **ASAM**, 100 mg/dia por 3 a 5 dias, em qualquer ordem com a glicose [4,11]. Na prova e na prática: tiamina antes do soro glicosado, sem nunca atrasar a glicose do hipoglicêmico [controverso quanto à ordem].

O QUE NÃO FAZER

Glicose antes da tiamina; fenitoína; clorpromazina; antipsicótico, clonidina ou betabloqueador como tratamento único; contenção sem sedação adequada; benzodiazepínico para casa sem avaliação ou em quantidade maior que a necessária [4,7].

SEÇÃO 5

Segurança do paciente com abstinência

Quase todo dano grave na abstinência é previsível — e, portanto, evitável.

A abstinência aparece fora da psiquiatria — na enfermaria, no pós-operatório, na UTI —, e o risco começa quando ninguém pergunta sobre álcool e a agitação do terceiro dia vira "delirium pós-operatório". As barreiras são quatro: **identificar o risco** na admissão (rastreio e PAWSS; na UTI, profilaxia em quem provavelmente é dependente) [4,9]; **não ancorar o diagnóstico** (glicemia, exame neurológico com marcha e olhos, busca de trauma, infecção e Wernicke) [4,7]; **dosar a sedação** com escala, frequência respiratória, oximetria e material de via aérea à beira do leito — lembrando que o subtratamento também mata [4]; e os **cuidados de ambiente**: precauções de queda, convulsão e aspiração, eletrólitos seriados, avaliação de suicídio e, na alta, o menor número de comprimidos [4,7].

A **contenção física** é exceção e ato médico: prescrita, justificada e registrada, com comunicação à família (Resolução CFM 2.057/2013) [12], feita por equipe treinada e retirada assim que o paciente estiver medicado [7]. Ela nunca substitui o benzodiazepínico: o paciente contido e subsedado luta contra as faixas e evolui com hipertermia, rabdomiólise e arritmia.

SEÇÃO 6

Tratamento da dependência

Desintoxicar é só o começo: o tratamento é longitudinal e combina abordagem psicossocial e fármaco.

O plano é centrado na pessoa [APA 2018 — 1C] e a meta — abstinência ou redução — é pactuada [APA 2018 — 2C] [13]; na dependência grave, na hepatopatia e na gestação, a abstinência é o objetivo clínico. A base psicossocial inclui entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental para prevenção de recaída, família, grupos de mútua ajuda e reinserção social [4,7,13]. A internação é a melhor hora de começar, inclusive com fármaco, com passagem direta ao CAPS AD ou à atenção primária [4]. A GGT ajuda a monitorar a adesão, e a recaída é tratada como parte da doença, sem culpabilização.

Fármaco	Como age e para quem	Dose	Principal cuidado
Naltrexona	Antagonista opioide; reduz o prazer de beber e a fissura [14]	50 mg/dia VO; não padronizada no SUS [15]	Contraindicada em quem usa opioide [13]; cautela na cirrose [14]
Acamprosato	Modula o glutamato; ajuda a manter a abstinência obtida [13,14]	666 mg três vezes ao dia (60 kg ou mais) [16]	Excreção renal: seguro na hepatopatia, contraindicado na insuficiência renal [14,16]

Fármaco	Como age e para quem	Dose	Principal cuidado
Dissulfiram	Bloqueia a aldeído-desidrogenase; age por aversão	Descontinuação referida em 2019 [14]	Contraindicado na hepatopatia; nunca sem o conhecimento do paciente [14]

Tabela 4 — Naltrexona e acamprosato são primeira linha no transtorno moderado a grave [APA 2018 — 1B]; topiramato e gabapentina *são alternativas [APA 2018 — 2C], e antidepressivo não trata o transtorno em si [13].*

SEÇÃO 7

Repercussões clínicas do álcool

O metabolismo explica boa parte da lista.

O etanol vira **acetaldeído** (tóxico e carcinogênico) e depois acetato, gerando excesso de NADH no fígado. Esse excesso inibe a gliconeogênese (hipoglicemia em jejum), desvia piruvato para lactato (que compete com o ácido úrico e precipita gota), favorece corpos cetônicos (cetoacidose) e síntese de gordura (esteatose). A indução do CYP2E1 torna o paracetamol hepatotóxico em doses menores.

Sistema	Principais repercussões
Fígado	Esteatose; hepatite alcoólica (icterícia, febre, AST/ALT acima de 2); cirrose. A abstinência é o único tratamento específico [14]
Digestivo	Pancreatite aguda e crônica, gastrite, hemorragia digestiva, tumores do trato aerodigestivo [7]
Coração	Hipertensão, cardiomiopatia dilatada, fibrilação atrial após grande ingestão (*holiday heart*) [7]
Nervoso	Convulsões, Wernicke e Korsakoff, degeneração cerebelar, neuropatia periférica, demência [7]
Sangue e metabolismo	Macrocitose, anemia por falta de folato, plaquetopenia, coagulopatia; hipoglicemia, hipocalemia, hipomagnesemia [7]
Outros	Hipogonadismo e ginecomastia, miopatia, depressão e suicídio, síndrome alcoólica fetal; câncer de boca, faringe, esôfago, fígado, cólon e mama [3,4,7]

Tabela 5 — Repercussões do uso crônico [3,7].

SEÇÃO 8

Outras drogas, tipo a tipo

A intoxicação mostra o efeito da droga; a abstinência, o efeito oposto.

As **depressoras** (álcool, benzodiazepínicos, opioides) dão, na retirada, hiperexcitação — fatal no álcool e nos benzodiazepínicos. As **estimulantes** (cocaína, crack, nicotina) dão cansaço, sono, fome, disforia e risco de suicídio, sem instabilidade autonômica. As **perturbadoras** (maconha, alucinógenos) alteram a percepção. O policonsumo é a regra [4].

8.1 Cocaína e crack

A intoxicação é **simpaticomimética**: midríase, sudorese, taquicardia, hipertensão, agitação, paranoia; as complicações graves são infarto, arritmia, dissecção de aorta, AVC, convulsão, hipertermia e rabdomiólise [17]. A dor torácica é investigada como síndrome coronariana [17]. O **benzodiazepínico trata quase tudo**: lorazepam 2 a 3 mg IV a cada 10 a 20 minutos, titulado (diazepam ou midazolam iniciando com 5 mg) [17]. Hipertensão persistente: nitroprussiato, nicardipina ou fentolamina; dor torácica: benzodiazepínico e, se preciso, nitrato; hipertermia: sedação e resfriamento [17]. O betabloqueador é contraindicado, porque deixa a vasoconstrição alfa sem oposição [AHA/ACC 2014 — classe III, dano] [17,18]. A abstinência traz depressão, sonolência, fome e fissura por semanas, com vigilância de suicídio; não há fármaco aprovado para a dependência, e o tratamento é psicossocial, pelo CAPS AD [17].

8.2 Opioides

Overdose: **miose, bradipneia e rebaixamento**, com morte por hipóxia [19]. Ventile e dê **naloxona** 0,4 mg IV a cada 2 a 3 minutos até 2 mg (2 mg de início se em apneia; IM e intranasal também servem); sem resposta com 10 mg, questione o diagnóstico [19,20]. Como a naloxona dura menos que muitos opioides, observe por 2 a 3 horas e interne quem usou opioide de ação longa [19]. A abstinência (midríase, piloereção, lacrimejamento, coriza, bocejos, diarreia; pico em 48 a 72 horas com a heroína) **raramente mata**; trata-se com metadona ou buprenorfina, ou com clonidina 0,1 a 0,2 mg VO a cada 4 a 6 horas e sintomáticos [19]. Na dependência, manutenção com **metadona** (estabilização em 60 a 120 mg/dia; prolonga o QTc, exige ECG) ou **buprenorfina** 8 a 24 mg/dia SL; a **naltrexona** só após 7 dias sem agonista [19]. Desintoxicar sem manutenção aumenta o risco de overdose fatal, pela perda da tolerância [19].

8.3 Benzodiazepínicos

A dependência nasce muitas vezes da receita, sobretudo no idoso, em quem o uso crônico aumenta quedas, fraturas e déficit cognitivo [21]. A intoxicação isolada raramente mata, mas com álcool ou opioide deprime a respiração; o **flumazenil** pode causar convulsão no usuário crônico e não é rotina [prática consagrada]. A abstinência se parece com a do álcool, com convulsão e delirium, por isso nunca **suspender de forma abrupta**. O desmame recomendado pela diretriz conjunta de 2025 é de **5% a 10% a cada 2 a 4 semanas**, sem passar de 25% em duas semanas, com terapia cognitivo-comportamental [21].

8.4 Maconha

A intoxicação dá euforia, hiperemia conjuntival, taquicardia e fome, às vezes pânico ou psicose; a abstinência é leve (irritabilidade, insônia). O que mais chega ao pronto-socorro é a **hiperêmese canabinoide**: vômitos cíclicos aliviados por banho quente em usuário crônico — pela AGA, pelo menos três episódios por ano, uso há mais de um ano e mais de quatro vezes por semana, com resolução após seis meses sem uso [22]. Na crise, o **haloperidol** 0,05 a 0,1 mg/kg IV superou a ondansetrona num ensaio pequeno, e a capsaicina tópica tem dados piloto [evidência limitada] [23]; o tratamento definitivo é **parar o uso**, com amitriptilina como opção preventiva [22].

8.5 Tabaco

No SUS, segue-se o PCDT de 2020 [MS/PCDT 2020] [24]: **aconselhamento estruturado** (quatro sessões semanais) e farmacoterapia. Só o aconselhamento basta para quem tem Fagerström de 4 ou menos, fuma até 5 cigarros por dia ou fuma o primeiro cigarro uma hora ou mais após acordar [24]. A **reposição de nicotina combinada** é a preferida: adesivo de 7 mg (6 a 10 cigarros), 14 mg (11 a 19) ou 21 mg (20 ou mais), iniciado no dia da parada, cerca de 1 mg por cigarro até 42 mg/dia, mais goma ou pastilha para a fissura [24]. A **bupropiona** é 150 mg pela manhã por três dias e depois 150 mg duas vezes ao dia até o 84.º dia, contraindicada na epilepsia e em outras condições de risco convulsivo [24]. Na gestante, só aconselhamento [24].

SEÇÃO 9

Políticas públicas e rede de cuidado

Cuidado em liberdade, base territorial e internação como exceção.

A **Lei 10.216/2001** (Reforma Psiquiátrica) priorizou serviços comunitários e prevê internação voluntária, involuntária e compulsória (judicial). A **RAPS** (Portaria 3.088/2011) tem a atenção básica, os CAPS, a urgência, os serviços residenciais transitórios e os leitos em hospital geral, com o projeto terapêutico singular como eixo [25]. O **CAPS AD** atende municípios com mais de 70 mil habitantes, e o **CAPS AD III**, 24

horas e com leitos de observação, acima de 200 mil; a Unidade de Acolhimento recebe por até seis meses, por indicação do CAPS [25].

A **Lei 13.840/2019** definiu que a internação involuntária do dependente é pedida por familiar ou responsável (ou servidor da saúde ou assistência, nunca da segurança pública), decidida por médico, dura no **máximo 90 dias**, é comunicada ao Ministério Público e à Defensoria em **72 horas**, não exige juiz e **nunca ocorre em comunidade terapêutica** [26]. A Política Nacional sobre Drogas de 2019 privilegia a abstinência e apoia as comunidades terapêuticas [27]; em 2023, a Portaria 757 revogou a reinclusão do hospital psiquiátrico na RAPS [28]; e em 2024 o STF descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal (até 40 gramas) [29]. Redução de danos e abstinência convivem [controverso]: na clínica, a meta é pactuada e muda com o tempo.

SEÇÃO 10

Pontos de prova e revisão

Se a questão traz...	Pense em...
Rebaixamento que não melhora em etilista que caiu	Hematoma subdural: tomografia
Convulsão generalizada no primeiro dia sem álcool	Benzodiazepínico IV, sem fenitoína
Vozes ameaçadoras com paciente orientado	Alucinose: benzodiazepínico e haloperidol
Confusão flutuante, alucinação visual e febre no terceiro dia	Delirium tremens: UTI e benzodiazepínico IV em doses altas
Confusão, ataxia e nistagmo em etilista desnutrido	Wernicke: tiamina em dose de tratamento antes da glicose
Cirrótico em abstinência / querendo manter abstinência	Lorazepam / acamprosato
Cocaína, dor torácica, taquicardia e hipertensão	Benzodiazepínico e nitrato; sem betabloqueador
Usuário de heroína que quer iniciar naltrexona	Esperar 7 dias sem agonista
Idosa em uso crônico de clonazepam	Desmame de 5% a 10% a cada 2 a 4 semanas
Município com 80 mil habitantes	CAPS AD (o AD III exige mais de 200 mil)

Tabela 6 — Associações frequentes em provas.

PEGADINHAS

A CIWA-Ar gradua, não diagnostica. Alcoolemia positiva não exclui abstinência. Clonidina, betabloqueador e haloperidol isolados mascaram a abstinência. Antidepressivo não trata o transtorno por uso de álcool. A abstinência de opioide raramente mata; a de álcool e a de benzodiazepínico, sim. Internação involuntária não depende de juiz, e comunidade terapêutica não interna ninguém.

Revisão em 30 segundos

DSM-5: 2 de 11 critérios em 12 meses; AUDIT de 20 ou mais, tratamento especializado. Intoxicação: suporte, glicemia, tiamina e busca de trauma. Abstinência: começa em 6 horas; diazepam (lorazepam no hepatopata), guiado pela CIWA-Ar; convulsão sem fenitoína; alucinose com consciência preservada; delirium em UTI com benzodiazepínico IV até sonolência leve; Wernicke com tiamina 200 mg três vezes ao dia. Depois da crise: naltrexona ou acamprosato e CAPS AD. Cocaína sem betabloqueador; opioide com naloxona; benzodiazepínico com desmame lento; tabaco pelo PCDT.

REFERÊNCIAS

Referências utilizadas

Fontes consultadas nesta elaboração

1. Fundação Oswaldo Cruz — ICICT. *III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira* — divulgação dos resultados. 2019. Disponível em: https:/www.icict.fiocruz.br/print/5255
2. Malta DC, et al. Convergência no consumo abusivo de álcool nas capitais brasileiras entre sexos, 2006 a 2019: o que dizem os inquéritos populacionais. *Rev Bras Epidemiol*. 2021;24(Supl 1):e210022. Disponível em: https:/scielosp.org/pdf/rbepid/2021.v24suppl1/e210022/pt
3. Organização Mundial da Saúde — Escritório Regional para a Europa. *No level of alcohol consumption is safe for our health*. 04/01/2023 (declaração publicada no *The Lancet Public Health*). Disponível em: https:/www.who.int/europe/news/item/04-01-2023-no-level-of-alcohol-consumption-is-safe-for-our-health
4. American Society of Addiction Medicine (ASAM). *The ASAM Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management*. J Addict Med. 2020;14(3S Suppl 1):1-72. Adotada em 23/01/2020. Disponível em: https:/www.asam.org/docs/default-source/quality-science/the_asam_clinical_practice_guideline_on_alcohol-1.pdf
5. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG. *AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test — Guidelines for Use in Primary Care*. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2001 — tabela de zonas de risco reproduzida em: https://bpac.org.nz/bt/2010/november/docs/addiction_AUDIT_interview.pdf
6. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA). *Alcohol Use Disorder: A Comparison Between DSM–IV and DSM–5*. Revisado em 2021. Disponível em: https:/www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/alcohol-use-disorder-comparison-between-dsm
7. Laranjeira R, Nicastri S, Jerônimo C, Marques AC; Departamento de Dependência Química da Associação Brasileira de Psiquiatria. Consenso sobre a Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) e o seu tratamento. *Rev Bras Psiquiatr*. 2000;22(2):62-71. Disponível em: https:/www.fmb.unesp.br/Home/ensino/Departamentos/Neurologia,PsicologiaePsiquiatria/ViverBem/Consenso_abstinencia_do_alcool.pdf
8. O'Malley GF, O'Malley R. Intoxicação e abstinência de álcool. *Manual MSD — Versão para Profissionais de Saúde*. Revisão completa dez/2022; última atualização dez/2025. Disponível em: https:/www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/tópicos-especiais/drogas-ilícitas-e-intoxicantes/intoxicação-e-abstinência-de-álcool
9. Maldonado JR, et al. Prospective Validation Study of the Prediction of Alcohol Withdrawal Severity Scale (PAWSS) in Medically Ill Inpatients: A New Scale for the Prediction of Complicated Alcohol Withdrawal Syndrome. *Alcohol Alcohol*. 2015. PMID: 25999438. Disponível em: https:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25999438/
10. Day GS, del Campo CM. Wernicke encephalopathy: a medical emergency. *CMAJ*. 2014;186(8):E295. Disponível em: https://www.cmaj.ca/content/186/8/E295
11. Ganatra RB, Breu AC, Ronan MV. Clinical Guideline Highlights for the Hospitalist: 2020 American Society of Addiction Medicine Clinical Practice Guideline on Alcohol Withdrawal Management. *J Hosp Med*. 2021 (15 dez). Disponível em: https:/mdedge.com/jhospmed/article/249617/hospital-medicine/clinical-guideline-highlights-hospitalist-2020-american
12. Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (CREMEB). Parecer sobre contenção de paciente com agitação psicomotora, com transcrição da Resolução CFM nº 2.057/2013. 2020. Disponível em: https:/cremeb.org.br/wp-content/uploads/2020/12/lsp_7109e2ee5eebd0115f4e7b0b2c86894f_021220-105659.pdf
13. American Psychiatric Association. *Practice Guideline for the Pharmacological Treatment of Patients With Alcohol Use Disorder*. Washington (DC): APA; 2018 — resumo das recomendações. Disponível em: https:/psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.books.9781615371969.alcohol03
14. Justus FF. Transtorno do uso de álcool: medicações reduzem óbitos e internações? *Portal Afya — Gastroenterologia*. 26/02/2026. Disponível em: https:/portal.afya.com.br/gastroenterologia/manejo-de-transtornos-associados-ao-alcool-o-que-o-hepatopata-deve-saber
15. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — NATJUS. Parecer Técnico nº 2292/2024 (naltrexona 50 mg). 20/06/2024. Disponível em: https:/portaltj.tjrj.jus.br/documents/d/guest/parecer-2292-2024
16. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Ficha técnica: Campral 333 mg comprimidos recubiertos (acamprosato). Disponível em: https:/cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/61201/FT_61201.pdf
17. Chary M. Cocaine. *MSD Manual — Professional Version*. Revisão completa e atualização jun/2026. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/professional/special-subjects/illicit-drugs-and-intoxicants/cocaine
18. American Heart Association / American College of Cardiology. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes — Tabela 18, grupos especiais (usuários de cocaína e metanfetamina), via Guideline Central. Disponível em: https:/eguideline.guidelinecentral.com/i/589485/27
19. Khan M, Makovkina E. Opioid Toxicity and Withdrawal. *MSD Manual — Professional Version*. Revisão completa jun/2026; última atualização ago/2026. Disponível em: https:/www.msdmanuals.com/professional/special-subjects/illicit-drugs-and-intoxicants/opioid-toxicity-and-withdrawal
20. Drugs.com. Naloxone Dosage — Usual Adult Dose for Opioid Overdose (baseado em bula norte-americana). Disponível em: https:/drugs.com/dosage/naloxone.html
21. ACP Internist Weekly. New guidance recommends tapering benzodiazepine use for most older adults (sobre a *Joint Clinical Practice Guideline on Benzodiazepine Tapering*, ASAM e sociedades parceiras, J Gen Intern Med, 2025). 24/06/2025. Disponível em: https:/immattersacp.org/weekly/archives/2025/06/24/2.htm

22. MDedge. AGA defines diagnostic, treatment approach to cannabinoid hyperemesis syndrome (sobre a *AGA Clinical Practice Update on Diagnosis and Management of Cannabinoid Hyperemesis Syndrome*, Gastroenterology, 2024). Disponível em: https://mdedge.com/content/aga-defines-diagnostic-treatment-approach-cannabinoid-hyperemesis-syndrome
23. Westafer L. Drugs for immediate relief of cannabinoid hyperemesis syndrome. *ACEP Now*. 24/02/2021. Disponível em: https://www.acepnow.com/article/drugs-for-immediate-relief-of-cannabinoid-hyperemesis-syndrome/
24. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Conjunta nº 10, de 16 de abril de 2020. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Tabagismo. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/pcdt/arquivos/2020/pcdt_tabagismo.pdf
25. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 (republicada). Institui a Rede de Atenção Psicossocial. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
26. Brasil. Lei nº 13.840, de 5 de junho de 2019. Altera a Lei nº 11.343/2006 e dispõe sobre o Sisnad e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13840.htm
27. Brasil. Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019. Aprova a Política Nacional sobre Drogas. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d9761.htm
28. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 757, de 21 de junho de 2023. Revoga a Portaria GM/MS nº 3.588/2017 e dispositivos das Portarias de Consolidação nº 3 e 6/2017. DOU nº 117, 22/06/2023. Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2023/06/U_PT-MS-GM-757_210623.pdf
29. Supremo Tribunal Federal. STF define 40 gramas de maconha como critério para diferenciar usuário de traficante (RE 635.659, Tema 506). Notícia de 26/06/2024. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-define-40-gramas-de-maconha-como-criterio-para-diferenciar-usuario-de-traficante/

Leitura complementar recomendada

- American Psychiatric Association. *Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais — DSM-5-TR*. Artmed.
- Diehl A, Cordeiro DC, Laranjeira R (orgs.). *Dependência química: prevenção, tratamento e políticas públicas*. Artmed.
- Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. *Compêndio de Psiquiatria de Kaplan & Sadock*. Artmed.
- Loscalzo J, et al. *Medicina Interna de Harrison* — capítulos de transtornos por uso de álcool e de outras substâncias. AMGH.
- Brasil. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001 (Reforma Psiquiátrica) e Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas).

Doses e critérios devem ser confirmados em bula vigente (Bulário Eletrônico da Anvisa) e nas diretrizes originais. A disponibilidade de medicamentos no SUS varia conforme as listas estaduais e municipais e não foi conferida item a item nesta elaboração, exceto onde indicado.

APÊNDICE · PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR · TUTORIA SEMANA 12

Francisco — problemas, metas e ações

Delirium tremens em transtorno por uso de álcool grave, com convulsões em abstinências prévias, hipoglicemia e hepatopatia alcoólica

Francisco, 52 anos, pintor autônomo. Trazido ao pronto-atendimento por vizinhos, gritando e quebrando objetos em casa. Bebe diariamente há mais de 20 anos, mais de 1 litro de cachaça por dia nos últimos 3 anos; parou há cerca de 24 horas após a internação da filha, para "virar a página". Evoluiu com inquietação, sudorese e tremor e, nas últimas horas, alucinações visuais e táteis, ideias persecutórias e agitação grave. Tentativas prévias de parar terminaram em recaída após cerca de 3 dias, com tremor, cefaleia e **crises convulsivas na abstinência**. Ao exame: agitado, desorientado no tempo, no espaço e quanto a pessoas, discurso desorganizado, pupilas midriáticas, PA 156 × 102 mmHg, FC 122 bpm, T 37,9 °C. Glicemia capilar 66 mg/dL; Na^+ 132 mEq/L; GGT 412 U/L; AST 78 e ALT 65 U/L; albumina 3,1 g/dL; INR 1,3. ECG registrado como "bradicardia sinusal leve".

1. Lista de problemas

#	Problema	Situação	Base
1	**Delirium tremens**	CONFIRMADO	Desorientação, alucinações visuais e táteis, agitação, tremor e hiperatividade autonômica cerca de 24 h após parar de beber
2	**Alto risco de convulsão** — abstinências complicadas prévias	CONFIRMADO	Convulsões em abstinências anteriores; recaídas repetidas sensibilizam o cérebro (kindling)
3	**Hipoglicemia**	CONFIRMADO	Glicemia 66 mg/dL; álcool inibe a gliconeogênese, provável jejum e hepatopatia
4	**Encefalopatia de Wernicke** possível	A ESCLARECER	Confusão e provável desnutrição (albumina 3,1) já somam dois critérios de Caine; marcha e movimentos oculares não avaliados
5	**Febre** (37,9 °C)	A ESCLARECER	Pode ser do delirium, mas pneumonia aspirativa e outras infecções precisam ser afastadas
6	**Hepatopatia alcoólica**, cirrose a definir	A ESCLARECER	GGT 412, AST > ALT, albumina 3,1, INR 1,3; faltam plaquetas, bilirrubinas e ultrassonografia
7	**Hiponatremia leve**	CONFIRMADO	Na^+ 132 mEq/L; corrigir sem pressa
8	**Potássio, magnésio e fósforo** não dosados	A ESCLARECER	Distúrbios frequentes no etilista; o magnésio importa pela convulsão prévia
9	**Hipertensão e taquicardia**	CONFIRMADO	PA 156 × 102, FC 122: descarga adrenérgica; reavaliar após benzodiazepínico
10	**ECG inconsistente**	A ESCLARECER	"Bradicardia" com FC de 122 bpm: repetir, definir o ritmo e medir o QTc
11	**Trauma craniano** não excluído	A ESCLARECER	Agitação com quebra de objetos em etilista com coagulação alterada
12	**Transtorno por uso de álcool grave**	CONFIRMADO	Consumo diário há 20 anos, tolerância, abstinência, tentativas fracassadas, uso apesar do dano
13	**Estressor agudo e risco de suicídio** não avaliado	A ESCLARECER	Filha internada; abstinência e depressão aumentam o risco
14	**Renda e rede de apoio**	A ESCLARECER	Autônomo, sem renda enquanto internado; companheira e vizinhos como rede

2. Metas

Meta	Prazo	Como se verifica
Paciente calmo, em sonolência leve e despertável, sem depressão respiratória	Primeiras horas	Escala de agitação e sedação, FR e oximetria seriadas
Glicemia normal e estável	Imediato	Glicemia capilar seriada
Nenhuma convulsão; delirium resolvido	3 a 5 dias	Exame do estado mental diário; delirium além de 72 h motiva reavaliação
Wernicke tratado ou afastado	Internação	Exame dos movimentos oculares e da marcha assim que possível
Causa da febre definida	24 a 48 h	Exame, radiografia de tórax, hemograma, urina e culturas se indicado
Eletrólitos corrigidos	24 a 72 h	Dosagens seriadas de Na^+, K^+, Mg^{2+} e fósforo
Hepatopatia estadiada	Antes da alta	Ultrassonografia, plaquetas, bilirrubinas, Child-Pugh
Tratamento da dependência iniciado, com meta pactuada	Antes da alta	Fármaco prescrito e plano registrado com o paciente
Vínculo com o CAPS AD e com a UBS	1.ª semana após a alta	Comparecimento ao acolhimento; contrarreferência recebida

LEITURA DO CASO — O QUE VEM PRIMEIRO

É um delirium tremens num paciente com convulsões em abstinências prévias, hipoglicêmico e com risco de Wernicke. Na primeira hora, quatro coisas decidem o desfecho: segurança e via aérea, glicose com tiamina em dose de tratamento, benzodiazepínico IV titulado até a sedação leve e a busca ativa do que costuma acompanhar o delirium — infecção, trauma e distúrbios eletrolíticos. O grupo acertou na internação, no jejum, na monitorização, na tiamina, no benzodiazepínico como base, na cabeceira elevada e no envolvimento da família.

3. Ações

CURTO PRAZO *Emergência e terapia intensiva, primeiras 72 horas*

Estabilização

- Leito monitorado, de preferência UTI: monitor cardíaco, oximetria, dois acessos venosos, cabeceira a 30°, jejum, ambiente calmo e com pouca luz.
- Contenção física só se a sedação não bastar, prescrita, justificada e registrada, retirada assim que possível.
- Material de via aérea à beira do leito.

Exames

- Glicemia capilar a cada 1 a 2 h até estabilizar.
- Hemograma com plaquetas, K^+, Mg^{2+}, fósforo, cálcio, ureia, creatinina, bilirrubinas, TP/INR, lipase, gasometria com lactato.
- Radiografia de tórax, urina e culturas se a febre persistir.
- ECG repetido, com ritmo e QTc.
- Tomografia de crânio se houver sinal focal, trauma ou rebaixamento desproporcional.

Prescrições

- **Tiamina** 200 mg IV de 8/8 h, antes da glicose ou junto dela, até o Wernicke ser afastado [10].
- **Glicose** hipertônica IV agora — a glicemia já é 66 mg/dL —, seguida de soro glicosado de manutenção.
- **Diazepam** 10 mg IV (no máximo 10 mg em 4 min), dobrando a cada 10 a 15 min até a sedação leve [7,8].
- Refratário: **fenobarbital** 120 a 240 mg IV a cada 20 min, na UTI [8].
- **Haloperidol** só se agitação e alucinações persistirem apesar do benzodiazepínico, com QTc conhecido [4,7].
- Cristaloide guiado pela volemia; repor K^+, Mg^{2+} e fósforo conforme exames; Na^+ corrigido devagar.
- Dipirona para a febre e resfriamento externo se necessário.

Vigilância e família

- Escala de sedação, FR, SpO_2, temperatura e balanço hídrico a cada hora no início.
- Precauções de queda, convulsão e aspiração.
- Com a companheira: confirmar quantidade, horário da última dose, convulsões prévias e outras drogas; explicar o quadro, considerando que a filha também está internada.

MÉDIO PRAZO *Enfermaria, até a alta*

- Delirium resolvido: benzodiazepínico por via oral com retirada gradual e suspensão antes ou logo após a alta.
- Tiamina por via oral; avaliação nutricional; folato e polivitamínico conforme exames.
- Estadiar a hepatopatia: ultrassonografia, Child-Pugh e, se houver cirrose, rastreio de varizes.
- Examinar movimentos oculares, marcha e memória antes da alta.
- Entrevista motivacional; meta de **abstinência**, pela hepatopatia e pela gravidade.
- **Acamprosato**, seguro na hepatopatia, após checar a função renal; dissulfiram contraindicado; naltrexona com cautela [13,14].
- Psiquiatria: humor, risco de suicídio, tabaco e outras drogas — inclusive solventes, aos quais o pintor tem acesso.
- Serviço social: renda do autônomo durante a recuperação e apoio à família.

LONGO PRAZO *Rede de atenção psicossocial e atenção primária*

- **CAPS AD** como referência: técnico de referência, PTS revisado com o paciente, grupos, mútua ajuda.
- **UBS** coordenando o cuidado: hepatopatia, pressão arterial reavaliada sem álcool, vacinação, retornos periódicos.
- Monitorar adesão com a conversa e a GGT; tratar a recaída como parte da doença.
- Plano de crise: a próxima abstinência é de alto risco — desintoxicação programada em hospital, nunca em casa.
- Família orientada e acolhida; grupos para familiares.
- Retorno ao trabalho com segurança, considerando tremor, escadas e alturas na fase inicial.

PONTOS A CORRIGIR NO QUE FOI DISCUTIDO NO QUADRO

1. **Glicose "se glicemia < 80":** a glicemia já é 66 mg/dL — a glicose é para agora, com a tiamina.
2. **Ringer 30 mL/kg/h:** são cerca de 2 litros por hora num adulto de 70 kg, excessivo para um hepatopata com albumina baixa; a hidratação é guiada pela volemia.
3. **Diazepam 10 mg reavaliado de hora em hora:** é esquema de abstinência simples. No delirium, bolus IV a cada 10 a 15 minutos, dobrando até a sedação leve, com doses totais altas [8].
4. **Tiamina 300 mg/dia:** é dose profilática; num paciente confuso e desnutrido, a dose deve ser a de tratamento do Wernicke até que ele seja afastado [10].
5. **Gluconato de cálcio:** sem indicação, pois o cálcio nem foi dosado; o que falta medir e repor é magnésio, potássio e fósforo [4].
6. **"Bradicardia sinusal leve"** com FC de 122 bpm: registro incompatível; repetir o ECG e medir o QTc antes do haloperidol.
7. **Avaliação incompleta:** faltaram hipoglicemia, hiponatremia, hepatopatia, febre, risco de Wernicke e risco de convulsão.
8. **Haloperidol sem dose nem critério:** só como adjuvante, depois do benzodiazepínico; metoclopramida apenas se houver vômitos.
9. **Encaminhamento só ao grupo da UBS:** o transtorno é grave, com delirium e convulsões; a referência é o CAPS AD, com a UBS coordenando, e o fármaco para a dependência começa na internação.

Fontes: diretriz da ASAM [4], consenso da ABP [7], diretriz da APA [13], revisão do CMAJ sobre Wernicke [10], Manual MSD [8] e as demais referências deste resumo. As condutas devem ser ajustadas ao exame à beira do leito e aos protocolos do serviço.